

MARIA APARECIDA MARCONDES DE ABREU RIZO

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRATICA EXERCICIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

25/09/23 P= 11,6 P95: 11,9
IAH= 1,7 e/h
média uso= 6h20'

Auto: P5 à 12 cmH₂O.

Princial: 4 cmH₂O.

⊕ Boca seca * usar micropare.

27/11
23 P= 11,9 cmH₂O
IAH= 1,7 e/h
m. de uso: 5h42'

último mês ajudando a mãe.

fla cláudia

26/02 P= 12,0 cmH₂O
24 IAH= 1,2 e/h

relata estar usando pouco

m. de uso: 4:00 todos os dias → (6h) flia

27/05/24 P= 5-12 cmH₂O / ↓ 11 cmH₂O
IAH= 1,4 e/h
m. de uso: 2h54m

~~relata~~ treco late da máscara / queixa
de salivação / Orienta observar medicamento +
uso constante

Natasha

24/6/24 P= 5- 11 cmH₂O
IAH= 1,3 e/h
m de uso: 3h20

Ainda cl dificuldade
na altura de boca

Natasha.

29/07/24 P= 10,3 cmH₂O (mediana)
IAH= 1,1 e/h
m de uso: 3h07'

13 dias s/ utilizar
Queixa que não
consegue ajustar a
máscara orienta ajuste
e higienização

Natasha

08/10/24 P= 10,2 cmH₂O
IAH= 1,3 e/h
m. de uso: 3:42'

Amixora e agitada
usa pouco

Natacha

07/01/2025 P= 10,6 cmH₂O.

IAH= 1,4 e/h
muro: 3h33 min

Silvi
não trabalha todo dia

14/04/25 P= 10,6 cmH₂O

IAH= 1,2 e/h
muro= 2h49 min

Auto 5 à 11 cmH₂O

deu P. fixa: 10,4 cmH₂O
↑ unidif: 5

Silvi

22/04/25 P= 10,4 cmH₂O

IAH= 0,9 e/h
muro= 5h18 min
fuga -

sentiu que despertou menos

nao pa 5 / mantendo P. fixa
* hoco filtrar

Silvi

14/07/25 P= 10,4 cmH₂O (fixa)

IAH= 0,9 e/h
muro= 5h50
fuga -

* hoco filtrar * sem despertares

mas dorme pouco pq acordar
mto cedo.

Silvi

MARIA APARECIDA MARCONDES DE ABREU MARQUES RIZO

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRATICA EXERCICIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

CAFE:

18/08

P= 12,0

IAH= 3,5

M. de uso: 6h27'

Bem adaptada, boca seca.
↑ unidif.

IAH= 309/ev

01/09

P= 13,7 cmH₂O

IAH= 1,7

M. de uso: 6h22'

fua

04/10

P= 14,9 cmH₂O

IAH= 7,3/ev

M. de uso: 7:17'

fua

09/11

P= 13,8

IAH= 1,2

M. de uso: 6:14 d. de uso - (5d. sluso) → 4:55h-

Acordou muito cedo, está tudo dormir muito tarde, bem adaptada.

fua

25/03

P= 13,8 cmH₂O

IAH= 1,1

M. de uso: 4h28'

Bem adaptada

fua

29/03

P= 13,9 cmH₂O

IAH= 2,2 e 9/ev

Fuga= 0,0

M. de uso: 6h20'

10/05

P= 11,9 cmH₂O

IAH= 1,3 e 7/ev

M. de uso: 6h15'

mediana ↓ a max. p 12.

fua.

24/07/23

P= 11,3 P90: 11,9 cmH₂O

IAH= 1,6 e 1h

M. de uso= 6h24'

* boca seca



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PNEUMOLOGIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificado em Medicina do Sono
Especialidade em Distúrbios do Sono
Mestre em Pneumologia pelo UNESP
Especialista em Distúrbios do Sono UNIFESP
CRM-SP: 69.730

Dra. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Especialista em Distúrbios do Sono
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Maria Aparecida Marcondes de Abreu Marques Rizo
EXAME nº: 5111
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 14/04/2022
IDADE: 60 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h09min e concluído às 05h24min. A latência para o sono foi de 0 minuto e a latência para o estágio REM, de 55 minutos. O tempo total de sono foi de 355,5 minutos (05h55min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 93,4%. A distribuição do sono mostrou 6,2% de estágio 1, 45,1% de estágio 2, 27,1% de estágio 3 e 21,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 24,5 minutos em vigília, ocorreram 81 microdespertares (índice: 13,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 35,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 30,9/hora, sendo 1 apneia/hora e 29,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 30,9/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (30,9/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (30,9/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 62; máxima: 83 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu imediatamente (latência para o sono: 0 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (55 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (93,4%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (13,7/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (27,1%; normal: 10-12%) e REM (21,5%; normal: 20%), e a redução do estágio 1 (6,2%; normal: 8-10%). A porcentagem do estágio 2 (45,1%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (35,8/hora; índice normal até 15/hora). Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 19 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM-SP: 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP: 69.730

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Maria Aparecida Marcondes de Abreu Marques Rizo

EXAME nº: 5111

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 14/04/2022

IDADE: 60 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h09min e concluído às 05h24min. A latência para o sono foi de 0 minuto e a latência para o estágio REM, de 55 minutos. O tempo total de sono foi de 355,5 minutos (05h55min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 93,4%. A distribuição do sono mostrou 6,2% de estágio 1, 45,1% de estágio 2, 27,1% de estágio 3 e 21,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 24,5 minutos em vigília, ocorreram 81 microdespertares (índice: 13,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 35,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 30,9/hora, sendo 1 apneia/hora e 29,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 30,9/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, sendo a saturação média de 91% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\hat{O}$ Tempo Total de Sono

TTR $\hat{O}$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (30,9/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (30,9/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 62; máxima: 83 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu imediatamente (latência para o sono: 0 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (55 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (93,4%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (13,7/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (27,1%; normal: 10-12%) e REM (21,5%; normal: 20%), e a redução do estágio 1 (6,2%; normal: 8-10%). A porcentagem do estágio 2 (45,1%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Aumento do índice de movimentos periódicos de membros (35,8/hora; índice normal até 15/hora). Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 19 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).